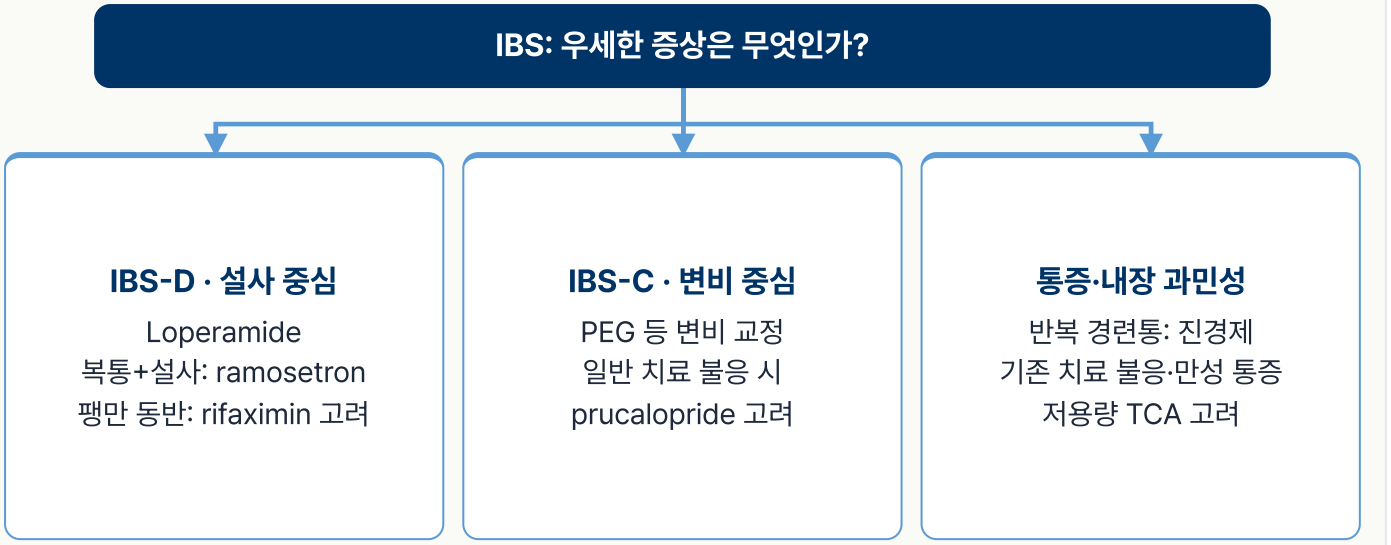
IBS 약제별 목표 증상·재평가·감량 기준표

한 약제의 목표 증상을 먼저 정하고, 효과와 부작용으로 유지·감량을 판단합니다.

증상으로 약제를 선택



Prucalopride의 선택적 사용은 연자 Q&A 의견입니다.

설사·복통 목표를 구분

약제	목표 증상·부작용
Loperamide	설사 횟수·변 형태 개선. 복통·전반적 IBS 증상 효과는 제한적. 변비·오심·복부팽만에 맞춰 조절.
Ramosetron	5-HT_3 길항제: 복통·설사·급박변·전반 증상 개선. 가장 흔한 부작용은 변비 → 감량 또는 중단.
Rifaximin	전신 흡수가 적은 장내 항생제. 팽만·dysbiosis가 두드러진 IBS-D에 선택. 14일 투여 후 재발하면 재치료 고려.

연자 Q&A 의견 · 처음부터 병용하지 않기

설사 중심이면 loperamide, 복통+설사면 ramosetron을 먼저 선택합니다. 한 약제로 불충분하면 병용하기도 하지만 일반적 전략은 아니며 변비·복부팽만을 주의합니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

IBS 약제별 목표 증상·재평가·감량 기준표

상세 확인 · 질환별 적용과 안전성

재평가·유지·감량 — 연자 Q&A 의견

약제	시점·판단 기준
Ramosetron	보통 2–4주 뒤 효과·변비 평가. 반응이 좋으면 수개월 이상 유지 가능. 장기 안전성 자료는 52주까지 보고; 주기적으로 지속 필요성·감량·중단 가능성을 평가.
Loperamide	저용량에서 증상에 맞춰 조절. 적정 용량 장기 사용 가능하나 변비·복부팽만·과량 복용 주의. 안정되면 감량·중단 시도.
Rifaximin	TARGET 연구: 550 mg 하루 3회, 14일. 연자 실제 처방: 국내 200 mg 제형을 고려해 400 mg 하루 3회, 약 2주. 치료 후 재평가; 반응 후 재발 시 재치료 고려.
TCA	저용량 시작, 2–4주 간격으로 효과·부작용 평가·조절. 효과가 있으면 수개월 유지, 안정되면 서서히 감량. 재발하면 이전 효과 용량으로 조절 가능.

! 신경조절제의 실제 안전 확인

01 강의: amitriptyline 10–25 mg 취침 전 시작. 고령은 더 낮게 시작. 졸림·구강건조·변비를 확인합니다.

02 연자 Q&A 의견: IBS-C의 변비 악화, 운전·고소 작업·위험 기계 조작 시 졸림에 특히 주의하거나 사용을 피합니다.

03 Nortriptyline은 항콜린 부작용이 상대적으로 적지만 강의·Q&A에서는 국내 사용이 어렵다고 설명했습니다.

04 여러 신경조절제를 동시에 추가하기보다 우세 증상·진단을 재평가합니다(연자 Q&A 의견).

장기 유지의 원칙 · 연자 Q&A 의견

모든 약을 평생 쓸 필요는 없습니다. 효과가 분명하고 반복 재발하면 장기 유지할 수 있지만, 최소 유효용량과 중단 가능성을 주기적으로 평가합니다.

IBS 약제별 목표 증상·재평가·감량 기준표

상세 확인 · 재평가·치료 조정

변비·경련·팽만 치료를 조정

선택	강의·연자 Q&A 의견
진경제	Pinaverium·mebeverine·trimebutine·cimetropium. 반복 경련통에 사용; 만성 통증·내장 과민성 우세 시 TCA 고려. 구강건조·변비·시야흐림·요저류(특히 고령) 주의.
PEG	변비 개선; 복통 개선은 placebo와 유의한 차이 없음. Lactulose보다 가스가 적음. IBS+FD 중첩에서 변비 교정만으로 상부 증상이 호전되기도 함(Q&A).
Lactulose · Prokinetics	Q&A: lactulose는 일반 용량에서 혈당 영향이 대체로 크지 않으나 제품 당류·복용량·혈당 고려, 가스·팽만 악화 가능. Prokinetics는 IBS에 일률적으로 사용하지 않음.
Probiotics	일부 균주에서 보조 효과, 제품·균주별 차이. 모든 환자에게 효과가 있지는 않음. 무증상 건강인에게 반드시 권할 필요 없음(Q&A).

약을 더하기 전에 — 연자 Q&A 의견

01 Low-FODMAP은 4–6주 평가. 무효면 지속하지 않고, 반응 시 재도입으로 개인별 허용 범위를 찾습니다.

02 Buspirone은 식후 증상이 두드러진 일부 FD에서 선택. Mirtazapine·escitalopram·duloxetine을 위장관 증상만으로 일상적으로 추가하지 않습니다.

03 Alprazolam·etizolam은 IBS 표준 치료제가 아닙니다. 장기 사용 시 내성·의존, 졸림·인지저하·낙상 위험; 특히 고령 주의.

감염성 설사와 구분 · 연자 Q&A 의견

수분·전해질 보충이 우선입니다. 면역 정상 성인의 단순 급성 수양성 설사에서는 loperamide를 쓸 수 있지만, 고열·혈변·염증성 설사 또는 C. difficile 감염 의심 시 피합니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-ibs-drug-reassessment/